検査部からの進言が契機となり早期診断に至ったヘアリー細胞白血病の一例

◎梶本 幸伸[1)]、荻谷 健也[1)]、村田 亘[1)]、伊藤 結衣[1)]、齋藤 実菜[1)]、新関 紀康[1)]、小谷内 克弥[2)]、山下 計太[1)]
浜松医科大学医学部附属病院[1)]、浜松医科大学医学部附属病院第三内科[2)]

【背景】古典的ヘアリー細胞白血病（Hairy Cell Leukemia：HCL）は，末梢血・骨髄に出現する有毛細胞と進行性の汎血球減少を特徴とする稀な成熟B細胞性腫瘍である.今回，汎血球減少と骨髄塗抹標本上の異常細胞所見から検査部が追加検査を提案し，早期診断に至った古典的HCL症例を経験したため報告する.

【症例】70歳代女性．5ヶ月前から進行する汎血球減少を認め，他科より精査目的で血液内科受診となった．末梢血検査では，WBC 3,070/μL，RBC 304×10⁴/μL，Hb 11.0 g/dL(前回値 10.5g/dL)，PLT 7.5×10⁴/μL と3系統の血球減少を認めた．MCV 111 fL と大球性貧血認め，白血球分画では単球1.0%，リンパ球72.3%，好中球14.1%であり，単球と好中球の減少を認めた．LDHは181 U/Lと基準範囲内であり，CRP上昇も認めなかった.

【検査所見】骨髄所見は，細胞密度やや低形成，3血球系統の減少を認めた．核形不整や切れ込み，核分葉傾向を有し，小型核小体を伴う中～大型の異常細胞が27.0%を占めていた．同細胞はペルオキシダーゼ染色およびエステラーゼ二重染色ともに陰性であった．典型的な有毛細胞にみられる細胞質突起は必ずしも明瞭ではなかったが，異常リンパ球性病変を疑い，sIL-2R追加測定を実施し14282 U/mLと著増を示した．上記所見よりHCL疑い，担当医にBRAF V600Eを提案した．FCMではCD19，CD20，CD22，CD79a陽性の成熟B細胞形質を示し，CD11c，CD25，CD123(20%程度)の共発現を認めた.骨髄生検では線維化を伴う異型リンパ球の増生を認めた．遺伝子検査でBRAF V600E変異陽性が確認され，古典的HCLと確定診断された.

【まとめ】本症例では，原因不明の汎血球減少に対し，骨髄塗抹標本上の異常リンパ球性病変を捉え，検査部から追加検査（sIL-2R測定およびBRAF V600E変異解析）を提案したことが，古典的ヘアリー細胞白血病の早期診断につながった．稀少血液疾患の診断支援において，検査部から積極的な情報提供と診断支援が重要であると考えられた.

連絡先： 053-435-2111（内線2787）